# KIT 3 – ABDOME AGUDO

**Referências:** ABRAMEDE 2024 • ATLS 10ª Edição • Ministério da Saúde – Protocolo de Abdome Agudo • SBAIT • SBAD

**Objetivo**

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem nos casos de abdome agudo, priorizando o raciocínio clínico, o reconhecimento precoce de causas cirúrgicas e a racionalização dos recursos laboratoriais e radiológicos no pronto-socorro.

## 1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Avaliar **características da dor** (localização, início, intensidade, irradiação, fatores de melhora/piora).
- Identificar sinais de **instabilidade hemodinâmica, peritonite, vômitos, distensão, febre ou sangramento**.
- Realizar **exame físico completo do abdome** (inspeção, ausculta, palpação, percussão, toque retal e vaginal quando indicado).
- **Não atrasar avaliação cirúrgica** em casos de abdome agudo evidente ou instabilidade.

## 2. EXAMES LABORATORIAIS

| Exame | Indicação de Solicitação | Evitar / Não Indicado |
|---|---|---|
| **Hemograma completo** | Avaliar leucocitose, anemia e sangramento oculto; solicitado em todos os quadros de abdome agudo. | — |
| **PCR / Procalcitonina** | Suspeita de abdome inflamatório/infeccioso (apendicite, diverticulite, colecistite, pielonefrite). | Casos de dor leve e transitória sem sinais sistêmicos. |
| **Ureia / Creatinina / Eletrólitos** | Avaliar função renal e distúrbios hidroeletrolíticos, especialmente em pacientes com vômitos ou sepse. | Casos leves sem repercussão sistêmica. |
| **Amilase / Lipase** | Dor epigástrica, vômitos, irradiação para dorso, suspeita de pancreatite. | Dor em outros quadrantes sem suspeita pancreática. |
| **TGO / TGP / FA / GGT / Bilirrubinas** | Dor em hipocôndrio direito, icterícia, colúria, náuseas — suspeita de colestase ou hepatopatia. | Dor em flancos, epigástrio ou hipogástrio sem icterícia. |
| **Urina tipo I / EAS** | Suspeita de ITU, pielonefrite, cálculo ureteral, disúria associada. | Dor abdominal sem sintomas urinários. |
| **β-hCG (teste de gravidez)** | Toda mulher em idade fértil (descartar gravidez ectópica). | Pós-menopausa ou esterilização comprovada. |
| **Gasometria + Lactato** | Sinais de choque, acidose metabólica, sepse, obstrução ou isquemia mesentérica. | Casos leves sem repercussão sistêmica. |
| **Função hepática completa** | Suspeita de hepatite, abscesso hepático ou colestase. | Casos sem icterícia nem alteração hepática clínica. |

**3. EXAMES DE IMAGEM**

| Exame | Indicação | Evitar / Não Indicado |
|---|---|---|
| **RX de abdome em ortostase e decúbito** | Suspeita de obstrução intestinal, íleo paralítico, perfuração (pneumoperitônio). | Dor leve sem distensão, sem vômitos e sem sinais de obstrução. |
| **RX de tórax PA/AP** | Pesquisa de pneumoperitônio (livre subdiafragmático). | Quando TC abdominal for disponível. |

**b) Ultrassonografia (USG / POCUS)**

| Exame | Indicação | Evitar / Não Indicado |
|---|---|---|
| **USG de abdome total** | Primeira escolha na maioria dos casos; diagnóstico de colecistite, apendicite, pielonefrite, ascite, abscesso, aneurisma de aorta. | Abdome distendido com alças gasosas (dificulta visualização). |
| **USG pélvico transvaginal** | Mulheres em idade fértil, dor pélvica, suspeita de gravidez ectópica ou cisto roto. | Pacientes do sexo masculino ou pós-menopausa. |

**c) Tomografia Computadorizada (TC)**

| TC | Indicação (Solicitar se) | Evitar / Não Indicado |
|---|---|---|
| **TC de abdome e pelve com contraste EV** | Dor intensa ou persistente sem diagnóstico definido, abdome agudo cirúrgico, pós-operatório com suspeita de complicação, sepse abdominal. | Dor leve autolimitada ou diagnóstico clínico evidente. |
| **TC sem contraste** | Avaliação de cálculo renal, obstrução urinária ou contraindicação ao contraste iodado. | Casos infecciosos e inflamatórios onde contraste é essencial. |
| **TC de abdome em trauma** | Avaliar lesões de órgãos sólidos e sangramento intra-abdominal (FAST positivo). | Trauma leve sem sinais abdominais. |

**4. PRIORIDADES**

- **Estabilizar hemodinamicamente antes dos exames.**
- **Evitar atrasar avaliação cirúrgica** em abdome agudo evidente.
- **USG é o exame inicial de escolha** na maioria dos casos.
- **TC é indicada apenas após avaliação clínica** e conforme critérios de gravidade ou incerteza diagnóstica.
- **Evitar duplicidade** de exames (RX + TC sem necessidade).

**Resumo Prático:**

| Cenário | Exames Laboratoriais | Exames de Imagem |
|---|---|---|
| **Apendicite / Diverticulite / Colecistite** | Hemograma, PCR, eletrólitos, função renal | USG abdome total ± TC com contraste |

| Cenário | Exames Laboratoriais | Exames de Imagem |
|---|---|---|
| **Pancreatite aguda** | Amilase, lipase, eletrólitos, função renal | USG abdome ± TC (48–72h se grave) |
| **Cólica renal / Pielonefrite** | EAS, creatinina, eletrólitos, hemograma | USG rins e vias urinárias ± TC sem contraste |
| **Gravidez ectópica / dor pélvica feminina** | β-hCG, hemograma | USG pélvico transvaginal |
| **Obstrução / perfuração / abdome cirúrgico** | Hemograma, lactato, função renal | RX abdome e tórax ± TC contrastada |
| **Dor leve, sem sinais de gravidade** | Nenhum exame inicial | Nenhum exame inicial |

**Conclusão**

A solicitação racional de exames no abdome agudo permite diagnóstico rápido e direcionado, reduz a exposição desnecessária a radiação e contraste, e otimiza o tempo de decisão cirúrgica.

- ✅ Diagnóstico precoce e seguro
- ✅ Menor sobrecarga do serviço
- ✅ Melhoria no fluxo de atendimento
- ✅ Redução de custos e tempo de permanência